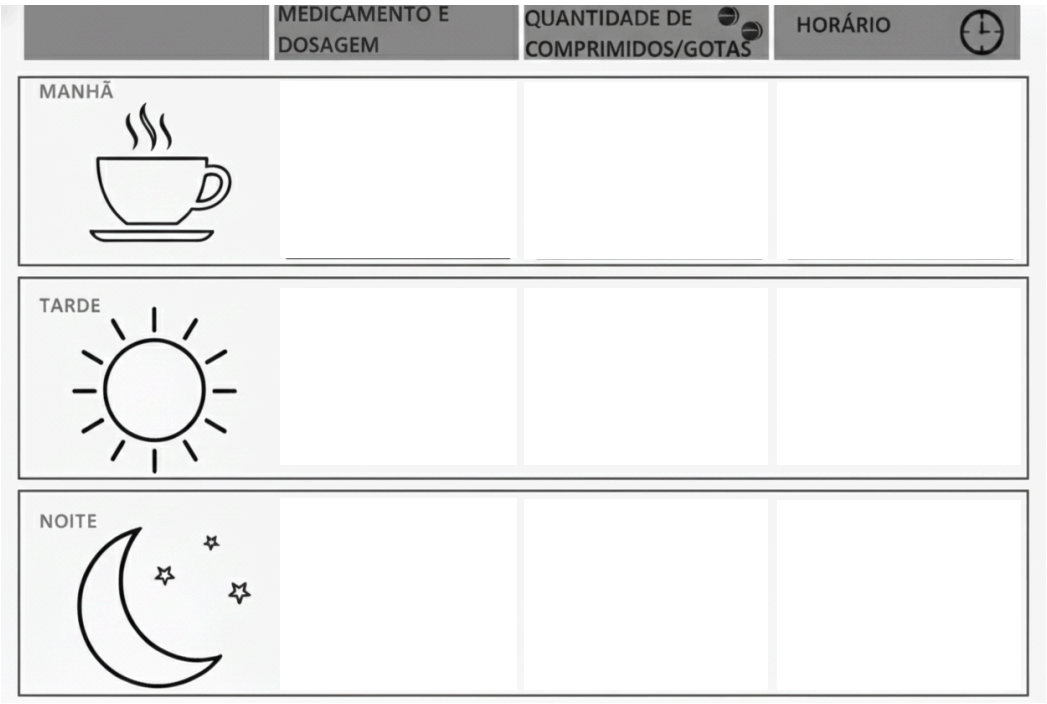
SALVAR COMO LIMPAR TUDO

PLANO DE VISITAS DOMICILIARES

DEVE SER PREENCHIDO PELO AGENTE COMUNITÁRIO RESPONSÁVEL PELA REGIÃO VISITADA JUNTAMENTE COM O PACIENTE E/OU SEUS RESPONSÁVEIS. O MÉDICO VISITANTE DEVE RECEBER ESTE MATERIAL PELO MENOS 72 HORAS ANTES DA VISITA PARA AVALIAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E CONDUTAS NECESSÁRIAS PARA UMA MELHOR VISITA..

PACIENTE:_____**IDADE:**_____
ENDEREÇO / TELEFONE _____
JUSTIFICATIVA DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR:_____
CUIDADOR PRINCIPAL (FAMILIAR OU NÃO):_____
COM QUEM O PACIENTE MORA: _____
QUADROS CUIDADOS:_____
PACIENTE É ALFABETIZADO:_____ **DATA DE NASCIMENTO:**____ **CPF:**_____



CUIDADOS COMPARTILHADOS COM OUTROS PROFISSIONAIS E SERVIÇOS COMO CRAS, CAPS OU MÉDICOS DO SERVIÇO PARTICULAR? NOMES E CONTATOS TELEFÔNICOS:

MOTIVO DA VISITA (ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO, QUEIXAS NOVAS, RETORNO PROGRAMADO). QUADROS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE NÃO POSSAM SER AVALIADOS IMEDIATAMENTE NO POSTO DE SAÚDE DEVEM SER AVALIADOS E DISCUTIDOS COM O SAMU (193) OU NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO(UPA):

ORIENTAÇÕES AOS PARENTES/CUIDADORES:

1.O CUIDADOR DO PACIENTE VISITADO, OU SEJA, O RESPONSÁVEL E CONHECEDOR DA ORGANIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E CUIDADOS DIÁRIOS, DEVE ESTAR PRESENTE DURANTE TODA A CONSULTA.

2.ÚLTIMOS EXAMES REALIZADOS PELO PACIENTE E DOCUMENTOS DE INTERNAÇÕES ANTERIORES DEVEM ESTAR SEPARADOS E DISPONÍVEIS PARA AVALIAÇÃO EM CASO DE NECESSIDADE. EM CASO DE EXAMES PRESENTES EM OUTRA LOCALIDADE QUE POSSAM SER ÚTEIS, É NECESSÁRIO QUE FAMILIARES PROVIDENCIEM FOTOS LEGÍVEIS DOS MESMOS (INCLUINDO DATAS DE REALIZAÇÃO).

3. OS FAMILIARES DEVEM ESTAR CONSCIENTES QUE NÃO SERÁ POSSÍVEL ATENDER À SOLICITAÇÕES DE TERCEIROS PARA RENOVAÇÕES, AVALIAÇÕES OU OPINIÕES MÉDICAS NO DIA DA CONSULTA.

_____
NOME E ASSINATURA DO ACS RESPONSÁVEL

_____
NOME E ASSINATURA DO PACIENTE / FAMILIAR

ÁREA DO MÉDICO

DATA DA CONSULTA:_____

ENDEREÇO (BAIRRO, RUA, NÚMERO E LINK PARA GEORREFERENCIAMENTO):

MORADORES NA CASA, IDADE, OCUPAÇÃO E LETRAMENTO:

TODOS REALIZAM AO MENOS TRÊS REFEIÇÕES POR DIA?_____
ÁGUA DE USO DOMÉSTICO É ENCANADA, CISTERNA, POÇO?_____
ÁGUA BEBIDA É SEM TRATAMENTO, FERVIDA, FILTRADA, HIPOCLORITO, MINERAL:_____
TRATAMENTO DO ESGOTO:_____NÚMERO DE QUARTOS/ BANHEIROS NA CASA _____/ _____
FORRO NA CASA?_____ ANIMAIS:_____ CORRIMÕES EM CHUVEIRO E PRIVADA:_____
TAPETES, DEGRAUS OU OUTRAS ÁREAS DE RISCO NA CASA?_____:
ASSENTO ELEVADO:_____ COLCHÃO PNEUMÁTICO:_____ COZINHA: GÁS, LENHA OU CARVÃO:_____
DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM PACIENTE OU PARENTE:_____
DIABETES EM PACIENTE E/OU PARENTE_____
HASC EM PACIENTE E/OU PARENTE_____
DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL EM PACIENTE E/OU PARENTE:_____
SENILIDADE SEVERA EM PACIENTE OU PARENTE:_____
RENDA MENSAL DO PACIENTE:_____ RENDA MENSAL DA FAMÍLIA:_____
GASTO MENSAL COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO:_____
CARTÃO DE VACINA EXISTENTE E (TIRAR UMA FOTOGRAFIA PARA CHECAGEM) E LACUNAS PRESENTES:
_____ img cartão vacina _____
GASTO ATUAL COM MEDICAMENTOS E TERAPIAS:_____
_____
RENDA MENSAL DISPONÍVEL PARA MEDICAMENTOS, EXAMES E TRATAMENTOS:_____

SOAP

Subjetivo (motivo da consulta, problema de saúde em questão, impressão subjetiva do profissional e expressadas pelo paciente, experiência do paciente com a doença ou problema relatado):

_____

Objetivo (dados do exame físico e exames complementares, incluindo exames laboratoriais disponíveis, IMC, PA, HGT):

Avaliação (definição e denominação possível dos problemas e queixas avaliados incluindo CIAP/CID):

Plano (cuidados e condutas frente às questões observadas, incluindo planos de diagnósticos ou acompanhamentos laboratoriais, planos terapêuticos, planos de acompanhamento e educação em saúde para paciente e sua família):

NOME DO MÉDICO, ASSINATURA E CARIMBO APÓS IMPRESSÃO: _____